Клинические рекомендации

Паратонзиллярный абсцесс

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J36** — Перитонзиллярный абсцесс **J39.0** — Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс **J39.1** — Другой абсцесс глотки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/664_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 2

2. Клиника и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Причины 2

2.3 Локализация 2

2.4 Клиническая картина 2

2.5 Жалобы и анамнез 3

3. Диагностика 3

3.1 Анализы 3

3.2 Дифференциальная диагностика 3

4. Лечение 4

4.1 Хирургическое лечение 4

4.2 Антибиотики 4

4.3 Другие лекарства 5

4.4 После вскрытия 5

5. Профилактика, госпитализация, осложнения 5

6. Источник и актуальность 5

6.1 Неточности в самом тексте КР 6

1. Главное

- Паратонзиллярный абсцесс лечит оториноларинголог в стационаре, и основа лечения — хирургическое вскрытие абсцесса.
- Чаще всего, более чем в 70% случаев, абсцесс располагается спереди и сверху — между капсулой миндалины и верхней частью передней дужки.
- Антибиотики широкого спектра, действующие и на анаэробы, назначают сразу, не дожидаясь посева; курс обычно 10–14 дней.
- При частых ангинах, повторном или затяжном абсцессе, плохом дренировании и кровотечении после вскрытия удаляют миндалины одновременно со вскрытием абсцесса.
- После простого вскрытия двустороннюю тонзиллэктомию делают планово через 3 месяца.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Паратонзиллярный абсцесс — гнойное расплавление клетчатки вокруг миндалины, между её псевдокапсулой и глоточной фасцией, покрывающей констрикторы глотки.

2.2 Причины

Чаще всего абсцесс развивается как осложнение ангины, реже — хронического тонзиллита. Возможен одонтогенный путь — от кариеса задних нижних зубов (вторых моляров, зубов мудрости) и периостита альвеолярного отростка, а также инфицирование инородным телом, например рыбной костью.

Возбудители — чаще всего бета-гемолитический стрептококк группы А и неспорообразующие анаэробы.

При обращении отёчная форма паратонзиллита встречается редко, инфильтративная — у 15–20%, абсцедирующая — у 80–85% пациентов. От начала болезни до абсцесса обычно проходит 4–6 дней, но иногда всего несколько часов.

2.3 Локализация

Передневерхний (супратонзиллярный) абсцесс — больше 70% случаев, между капсулой миндалины и верхней частью передней дужки. Задний — около 15%, между миндалиной и задней дужкой. Нижний — чуть больше 5%, между нижним полюсом миндалины и боковой стенкой глотки. Боковой — меньше 5%, между средней частью миндалины и боковой стенкой глотки.

2.4 Клиническая картина

Абсцесс обычно возникает на фоне ангины или через несколько дней после неё. Сначала появляется боль при глотании, которая становится постоянной, резко усиливается при попытке проглотить слюну и отдаёт в ухо и зубы. Беспокоят головная боль и разбитость, температура поднимается до фебрильной, пациенты отказываются от еды и питья. Почти всегда постепенно нарастает тризм, речь становится невнятной и гнусавой. Из-за боли при поворотах пациент держит голову набок и поворачивается всем корпусом.

При передневерхнем абсцессе верхний полюс миндалины вместе с дужками и мягким нёбом резко выбухает к средней линии, язычок смещён в противоположную сторону, миндалина оттеснена книзу и кзади.

При заднем абсцессе припухлость видна в области задней дужки, процесс может переходить на боковую стенку глотки; миндалина и передняя дужка мало изменены, язычок и мягкое нёбо отёчны.

При нижнем абсцессе в глотке видны лишь отёк и инфильтрация нижней части передней дужки, хотя жалобы выражены. Может вовлекаться корень языка, иногда отекает язычная поверхность надгортанника, и отёк, распространяясь на гортань, может привести к её стенозу.

Боковой абсцесс встречается реже всего, но протекает тяжелее всех: гною трудно прорваться в глотку. Выражены отёк и инфильтрация мягких тканей шеи на стороне поражения, кривошея и тризм, а в глотке видно лишь умеренное выбухание всей миндалины.

2.5 Жалобы и анамнез

Важно узнать о недавних ангинах, хроническом тонзиллите, прошлых паратонзиллитах и абсцессах и их лечении, о кариесе и возможном инородном теле, например рыбной кости.

Характерны сильная, обычно односторонняя боль в горле, усиливающаяся при глотании и отдающая в ухо и зубы, ощущение инородного тела, гнусавость, неприятный запах изо рта, боль в шее при поворотах головы, тризм и слюнотечение. Из общих жалоб — слабость, разбитость, фебрильная температура и головная боль; они неспецифичны и требуют дифференциальной диагностики.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу, осмотру с тщательной оценкой подчелюстной области и лимфоузлов, фарингоскопии и анализам.

Каждого пациента с подозрением на абсцесс осматривает оториноларинголог.

Местные признаки, наиболее выраженные при переднем абсцессе: яркая гиперемия, отёк и инфильтрация дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка, асимметрия мягкого нёба, смещение миндалины, ограничение открывания рта, регионарный лимфаденит.

Фарингоскопию проводят всем детям и взрослым; её данные решают диагноз.

Если есть подозрение, что воспаление распространилось на гортаноглотку, проводят непрямую ларингоскопию или фиброларингоскопию.

КТ и УЗИ шеи делают в тяжёлых случаях, когда нужно уточнить диагноз и локализацию абсцесса или отличить его от воспаления глубоких отделов шеи.

3.1 Анализы

Всем делают развёрнутый анализ крови, СРБ и анализ мочи. Высокий лейкоцитоз со сдвигом влево и высокий СРБ говорят о высоком риске осложнений и требуют коррекции лечения, в том числе антибиотиков.

Гной после вскрытия отправляют на посев на аэробы и анаэробы с определением чувствительности, а мазок с миндалин — на дифтерийную палочку, чтобы исключить дифтерию.

Лучше брать не сам гной, а смыв или мазок со стенок полости: ферменты гноя разрушают микробы. Материал доставляют в лабораторию в транспортной среде, оптимально за 40 минут.

3.2 Дифференциальная диагностика

Абсцесс отличают от дифтерии, скарлатины, абсцесса язычной миндалины, абсцессов подъязычной области, флегмоны дна полости рта, опухолей ротоглотки и перикоронита.

При дифтерии слизистая бледно-цианотичная, налёты сероватые и выходят за пределы миндалин, но тризма нет.

При скарлатине есть сыпь на коже, чёткая граница поражённой слизистой и «малиновый» язык. При абсцессе язычной миндалины нет тризма и типичных изменений в ротоглотке. При флегмоне дна полости рта боль и отёк в подчелюстной области, язык малоподвижен, а дужки и миндалины не изменены.

Опухоли миндалины развиваются медленно, без температуры, сильной боли и тризма, а лимфоузлы плотные, малоболезненные и малоподвижные.

Изредка припухлость в глотке вызвана близко расположенной сонной артерией или её аневризмой; диагноз подсказывает видимая пульсация.

---

4. Лечение

Пациента лечит оториноларинголог в специализированном учреждении; основа лечения — хирургическая санация полости абсцесса.

4.1 Хирургическое лечение

Впервые возникший абсцесс вскрывают и дренируют.

Правила при любой технике: убедиться, что в месте вскрытия нет пульсации; глубже 0,5 см продвигаться только тупым путём; вскрывать достаточно широко, до 4 см.

Разрез выбирают по локализации, под местной аппликационной анестезией. Передневерхний абсцесс вскрывают через переднюю дужку в типичном месте или в месте наибольшего выбухания, задний — через заднюю дужку, отступив 0,5 см от края, нижний — в нижней части передней дужки. Ткани рассекают вдоль сосудов на глубину 0,5–1 см, дальше раздвигают корнцангом.

Затем регулярно разводят края разреза, пока полость не начнёт заживать.

При частых ангинах в анамнезе, повторном паратонзиллите или абсцессе, затяжном течении, плохом дренировании и кровотечении после вскрытия удаляют нёбные миндалины одновременно со вскрытием абсцесса: так убирается и сам очаг инфекции.

Такую операцию делают в любом возрасте, от 3–4 до 70 лет и старше. Противопоказания — терминальное или крайне тяжёлое состояние из-за болезней внутренних органов, тромбоз сосудов мозга, разлитой менингит.

После операции осматривают нишу миндалины: выпячивание в ней — признак парафарингеального абсцесса.

4.2 Антибиотики

Системные антибиотики назначают сразу, не дожидаясь посева. Так как в абсцессе обычно есть анаэробы, нужны препараты широкого спектра, которые действуют и на них.

Препарат	Доза
Амоксициллин и клавулановая кислота	С 12 лет или с массой от 40 кг — 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки. Можно #амоксициллин с сульбактамом по 1 г 2–3 раза в сутки с 12 лет, до 10 дней. Детям до 12 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Цефтриаксон	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки; длительность в таблице КР указана так: «в течение 4–14 дней до 10 дней». Новорождённым до 2 недель — 20–50 мг/кг 1 раз в сутки, не больше 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки.
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 1 г 2 раза в сутки, до 10 дней. Новорождённым и детям до 12 лет — 50–100 мг/кг в сутки с интервалом 6–12 часов; недоношенным — не больше 50 мг/кг в сутки.

Препарат	Доза
Клиндамицин	300 мг 2 раза в сутки, при тяжёлом течении — до 1,2–4,8 г в сутки в 2–4 приёма. Детям при непереносимости цефалоспоринов III поколения — #20–40 мг/кг в сутки в 3–4 приёма.

Курс обычно 10–14 дней. Препараты выбора — пенициллины, в том числе с ингибиторами бета-лактамаз. Если глотать таблетки трудно, используют диспергируемые формы, суспензии или инъекции. При выраженном отёке тканей глотки и шеи, сильном тризме и высоком риске генерализации назначают парентеральные цефалоспорины III поколения, а при их непереносимости — клиндамицин. Детям предпочтительны ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой.

4.3 Другие лекарства

При выраженных воспалительных проявлениях назначают НПВП в обычных дозах.

Всем назначают системные антигистаминные препараты.

КР рекомендует и средства для повышения сопротивляемости — препараты кальция, витамины С и А, — избегая полипрагмазии.

При выраженной интоксикации проводят инфузионную дезинтоксикационную терапию.

Всем назначают местные противовоспалительные, обезболивающие и антисептические средства: полоскания, инсуффляции, ингаляции, таблетки для рассасывания. Системные антибиотики они не заменяют.

После операции, не раньше чем через 3 недели после стихания воспаления, пациента консультирует физиотерапевт.

4.4 После вскрытия

После вскрытия абсцесса двустороннюю тонзиллэктомию делают планово через 3 месяца.

После тонзиллэктомии месяц ограничивают физическую нагрузку.

5. Профилактика, госпитализация, осложнения

При диспансеризации выявляют факторы риска — хронический тонзиллит и рецидивирующие ангины; профилактика включает закаливание и своевременное лечение зубов и дёсен.

Лечат в хирургическом стационаре. Показание к госпитализации — необходимость вскрыть абсцесс или удалить миндалины со вскрытием абсцесса. После вскрытия состояние улучшается уже через 12–24 часа. После абсцесстонзиллэктомии без осложнений выписывают на 5–7-е сутки.

Без лечения или при неправильном лечении высок риск гнойных осложнений: флегмоны шеи, медиастинита, тонзиллогенного сепсиса, инфекционно-токсического шока. Риск выше при иммунодефиците — врождённом, на иммуносупрессорах и цитостатиках, при ВИЧ.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Паратонзиллярный абсцесс»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	664_2 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Для цефтриаксона в таблице 1 написано «в течение 4-14 дней до 10 дней» — сроки противоречат друг другу; на сайте указано «до 10 дней».
- Знак # у амоксициллина с сульбактамом и у детской дозы клиндамицина означает применение вне инструкции.